

• 药物与临床 •

药物相互作用

六、抗精神病药	处 理
吩噻嗪类 • 中枢抑制药: 中枢抑制作用增强。 • 制酸药、收敛性止泻药: 吩噻嗪类口服吸收减少。 • 苯海索: 减轻吩噻嗪类锥体外系不良反应, 但 M 受体抑制加重。 • 苯海拉明: 同上 • 肾上腺素: 肾上腺素的升压作用被翻转(α作用被阻滞, 仅现 β作用), 出现血压剧降, 心动过速。 • 左旋多巴: 抗震颤麻痹效应受抑制。 • 三环类抗抑郁药, 单胺氧化酶抑制剂: 抗胆碱作用增强时效延长。 氟哌啶醇 • 中枢抑制药: 中枢抑制作用加强, 血压下降, 昏迷。 • 抗高血压药: 血压过度降低。 • 肾上腺素: 氟哌啶醇的作用类似吩噻嗪, 可出现血压剧降, 参见吩噻嗪类。 • 抗胆碱药: 参见吩噻嗪类中苯海索条。 氯普噻吨(泰尔登) 参见吩噻嗪类	宜减量使用 不宜同服 可小心联用 禁忌 作用相反, 应为禁忌 注意减量或不联合应用 禁用, 必要时应监护方可应用 必须谨慎减量
氯氮平 • 碳酸锂: 可致惊厥、恶性综合征、精神错乱和肌张力障碍。 • 抗胆碱药: 抗胆碱作用加强。 • 中枢抑制药: 中枢抑制作用加强。	不可联用 注意控制剂量 注意减量
七、抗抑郁药	处 理
三环类抗抑郁药 • 乙醇: 中枢抑制作用加重。 • 抗胆碱药, 抗组胺药: 抗胆碱作用加强。 • 雌激素类: 三环类不良反应增强, 抗抑郁效能降低。 • 单胺氧化酶抑制剂: 可产生高血压危象。 • 肾上腺素能受体激动药: 可产生严重高血压和高热。 • 抗惊厥药: 三环类降低癫痫阈值, 需调整抗癫痫药用量。 马普替林 • 抗组胺药: 抗胆碱作用加强。 • 西咪替丁: 抑制马普替林代谢, 加强作用。 • 单胺氧化酶抑制剂: 同三环类, 见上。 • 氟西汀: 两药血浓度均升高。 • 甲状腺素: 可致心律失常。	用药期间戒酒 谨慎 不宜联用 单胺类停用 2 周后方可用三环类 禁忌 监测 注意 调整药量 不宜联用 不宜联用 不可联用
八、抗躁狂药	处 理
碳酸锂 • 肌松药: 肌松作用增强, 时效增长。	警惕, 注意用量

• 去甲肾上腺素: 升压效应下降。 • 茶碱(氨茶碱)、咖啡因: 尿排出量增加, 血锂浓度降低。 • 钠盐: 促使锂盐排泄, 低钠可致锂潴留而中毒, 高钠则又使锂盐降解。 • 碘化物: 两者联用可引起甲状腺功能低下。 • 吩噻嗪类: 使氯丙嗪血浓度降低 40%, 锂中毒症状被掩盖。	注意 监测 监测 加强观察 加强观察
---	--------------------------------

(待续)

生霉中药的去霉方法

赵 青

在中药的储存中, 常常见到生霉现象, 下面就谈谈生霉药材的去霉方法。

1 撞刷法

发霉不严重的药材经日晒或烘烤干透后, 可装入撞笼或麻袋里来回摇晃, 使药材通过摩擦去霉。长条状的药材生霉经晒干后, 可用刷子刷去霉。注意: ①药材必须干燥, 受潮药材无法去净霉迹。②花类药材生霉宜阴干, 不宜曝晒以免花朵变色。

2 抢水洗法

所谓抢水洗法即将药材投入清水中, 快速洗涤及时取出。由于药材与水接触时间短。故称“抢水洗”。根茎类药材生霉大多可采用抢水洗方法将霉去掉。但麦冬、怀牛膝、玉竹等这些品种不宜抢水洗去霉, 因水洗会加速泛油和变色。对天冬等品种生霉宜用温水洗, 并在温水中加少许白矾, 以免洗后发粘, 不易干燥。对洗后要求颜色鲜洁者, 可待药材洗去霉稍晾干后每 10 kg 药材用硫磺 40~50 g 熏蒸后再晒干。

3 沸水喷淋法

药材发霉后不宜水洗者, 可将药材薄摊, 喷淋沸水, 不断翻

动, 待药材喷湿后将其堆在一起闷 1 小时, 再用少许硫磺熏蒸后取出晒干即可。注: 本法水温要求 90℃ 以上, 水珠喷得细而均匀。药材要翻动。

4 酒洗去霉法

某些药材如大黄、熟地等酒制品生霉时, 可将药材摊开、喷酒; 不断翻动, 喷后闷渍 1~2 小时, 再摊开晾干, 一般 10 kg 药材用酒 0.6~1kg。另有些长条状药材生霉如人参, 可用刷子蘸酒刷去霉。

5 醋洗法

某些不宜沾水和醋制的药材生霉后, 如山茱萸、五味子可用醋喷洗去霉。一般 10 kg 药材用醋 0.5~0.6kg 即可。

6 油擦法

不能见水见热的药材如附片生霉后, 可用布沾食用植物油在药材上搓擦。除以上方法外, 其他还有烘烤法、热蒸法去霉。但不管采用哪一种方法只能起到除霉作用, 而不能挽回质量和经济上的损失。因此在工作中我们绝不能以为药材生霉后能整理去霉而放松防霉工作。

(收稿: 2001-03-05 修回: 2001-04-10 编辑: 辛 雨)

作者单位: 421400 湖南省衡东县中医职业中专

甲氧氯普胺致锥体外系症状 30 例分析

邓 涛

甲氧氯普胺(胃复安)可通过阻滞多巴胺受体而作用于延脑催吐化学感应区, 具有强大的中枢性镇吐作用。我院 1993~1999 年收治甲氧氯普胺治疗呕吐引起锥体外系症状者 30 例。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 30 例中, 男 16 例, 女 14 例; 年龄 5 个月至 1 岁 12 例, 1 岁~9 例, 2 岁~6 例, 3 岁以上 3 例。

1.2 用法 甲氧氯普胺肌注一次剂量 0.3mg/kg, 成人肌注剂量 10mg/次。

1.3 临床症状 出现症状均在肌肉注射后 5 分钟至 1 小时, 其表现为: 颈强直及斜颈 23 例, 牙关紧闭 18 例, 四肢痉挛 14 例, 面部痉挛 12 例, 手足震颤 8 例, 眼球转动 6 例, 角弓反张 2 例。

1.4 治疗 轻微症状, 停药自愈。症状较重者 24 例, 用山莨菪碱(654-2)、地西泮(安定)对症治疗, 症状全部消失。

2 讨论

甲氧氯普胺是多巴胺受体阻断剂, 其中枢作用为止吐, 周围作用为增加胃排空和减少十二指肠反流, 从而提高食物通过率, 这些作用也可增强本品的镇吐效应。本品可能因阻断多巴胺受体, 使胆碱能受体相对亢进, 而导致锥体外系统兴奋, 症状表现为阵发性头往后仰、牙关紧闭、斜颈、颈强直、口唇青紫、流涎、行走不稳、肌肉抽动等症状。发作持续时间约 5~10 分钟, 可自行缓解, 缓解后进入昏睡状态, 醒后一切如常。

甲氧氯普胺用于治疗婴幼儿呕吐在农村基层卫生院比较广泛, 因其价格低、效果好, 医师及家属均容易接受。但小儿中枢神经系统发育不健全, 多巴胺分泌量较少, 甲氧氯普胺更易引起锥体外系症状。故小儿应慎用甲氧氯普胺, 尤其是 2 岁以内的婴幼儿最好不用。必须使用时, 单次剂量尽量控制在 0.3mg/kg 内, 且在 24 小时内最好不重复使用。

(收稿: 2000-10-19 编辑: 周维金)

作者单位: 523320 广东省东莞市石龙人民医院